



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : نسمة حسن شرقاوي احمد حسين

العنوان : =

المحافظة : الجيزة

رقم البطاقة : 29112072102403 رقم التليفون : 01007565201

تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 07-12-1991 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي

المقر بما فيه

التوقيع: (-----) (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة : -----

الوظيفة : -----

الوظيفة : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : -----

قسم : -----

جهة العلاج : -----

نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نسمة حسن شرقاوي احمد حسن National ID: 29112072102403	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



تسميه

حسن شرفاوى احمد حسين

١٢ قرية ميت رهينه

مركز البدرشين - الجيزة

٢٠١١/١٢/٢٧

٢٠١١/١٢/٢٧ ٢١ ٠٢٤ ٠٣

IS0598576



٢٠٢٠/١٢ ٢٠١١/١٢/٢٧ ٢١ ٠٢٤ ٠٣

حاصله على بكالوريوس تجارة

شعبة محاسبة

أنثى متزوجة

حسام عبدالمنعم عبدالله جميلين حسين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١٢/٢٧





Name: Nesma Hassan

Date: 30/11/2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Status post right breast operative intervention with implant insertion.
- Right upper lobar apical benign tiny (2-3 mm) pulmonary nodule.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes apart from few calcified nodes (post granulomatous).
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is moderately enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Enlarged spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows no definite lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

A reported case of operated right breast carcinoma showing:

- ***No definite pulmonary , hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.

Pathology Report

Name: نسمة حسن شرقاوي احمد

Age: 29 years.

Clinical data: Breast cancer.

Specimen type: Slide revision.

Date(Received) : 30 /1/2021

Date(reported): 14 /2/2021

Lab. Number: Sr -29/21

Hospital Number: 2021/ نفقة دولة

Gross Description:

10 Stained H and E slides and 10 blocks (1179) by patient name.

Microscopic Examination:

Slides and blocks revised show reactive changes of tumor bed of previous conservative tumor excision. Only focal in situ carcinoma is evident.

Blocks of Tru – cut biopsy or conservative tumor excision are needed for diagnosis and markers study.

Diagnosis:

Breast, Slide revision.

Focal DCIS in completion mastectomy slides.

Faraffin blocks of invasive tumor biopsy or excision are needed.



Prof. Dr. Iman Gouda.



خطابات أورام

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

معهد ناصر
مركز الأورام



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Nesma Hassan

Date: 4/3/2021

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- No definite focal active or cold osseous lesions could be seen all over the scanned skeleton to account for definite bone metastasis.
- Otherwise the rest of the scanned body is unremarkable.
- Both kidneys are seen

Conclusion:

- ***The skeleton appeared free from definite metastatic deposits.***

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Omnia Talaat .MD

Magdy kotb , MD



Pathology Report

Name: نسمة حسن شرقاوي احمد

Age: 29 years.

Clinical data: Breast cancer.

Specimen type: Slide revision.

Date(Received) : 30 /1/2021

Date(reported): 14 /2/2021

Lab. Number: Sr -29/21

Hospital Number: 2021/ دوله

Gross Description:

10 Stained H & E slides and 10 blocks (1179) by patient name.
Additional 3 immunostains slides and 7 blocks submitted.

Microscopic Examination:

Slides and blocks revised show reactive changes of tumor bed of previous conservative tumor excision. Only focal in situ carcinoma is evident

Additional slides show invasive duct carcinoma grade III, with major CIS.

- Sections examined for Estrogen receptors revealed strong nuclear positivity in 90% of the tumor cells .
- Sections examined for Progesterone receptors revealed strong nuclear positivity in 60% of the tumor cells .
- Sections examined for Her2 revealed strong complete membranous reactivity in more than 10% of tumor cells

Diagnosis:

Breast, Slide revision.

- Invasive duct carcinoma with major DCIs. Grade III.
- Positive for ER receptor. Score (8/8).
- Positive for PR receptor. Score (7/8).
- Positive for Her2. Score 3+ .

*Prof. Dr. Iman Gouda.
Dr. Marwa Mahmoud*



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
هرمل سابقاً

No.: 11

درجہ اول

د/محمد شريف
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

د/ أحمد فهم
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

د/ سمية عبد الحليم
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

Name	نسمة حسن	Age	28 ys	Code	954 - 20
Referred by	الد. مروة الديب	Date	29/10/2020	Sex	Female
Clinical data	Right UOQ breast lesion BIRADs 4a				
Specimen	Ultrasound guided tru-cut biopsy				

PATHOLOGY REPORT

GROSS:

Multiple cores, totally submitted.

MICROSCOPIC PICTURE Sections examined revealed invasive malignant growth formed of solid groups and cords of malignant medium sized ductal cells showing moderate nuclear atypia surrounded by desmoplastic stroma. Foci of high grade necrotizing DCIS (comedo) were also seen.

DIAGNOSIS Breast mass, US guided core biopsy:

- Infiltrating Duct Carcinoma (NST), Grade II, associated with Foci of High Grade DCIS.

Dr. Soma Salama, MD

Dr. Ahmed Nabil, MD

Dr. Mohamed Elmaghrabi, MD

01142299928

0235936015

01142299928



برج نؤلوة فيصل - شارع فيصل الرئيسي - أمام كلية التربية الرياضية - الدور الثاني
Faisal Pearl Tower in front of Faculty of Physical Education - Second Floor



02 35936015 - 01142299928

01142299928 - 02 35936015



د/ محمد شريف
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

د/ أحمد نعيم
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

د/ سميرة عبد الحليم
استشاري الباثولوجي
مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

Name	نسمة حسن شرقاوي	Age	29Y	Code	1179 - 20
Referred by	أ.د/ مروة الديب	Date	10/12/2020	Sex	Female
Clinical data	Right breast mass				
Specimen	1). Right completion mastectomy. 2). Right axillary fibrotic nodule. 3). Fibrotic nodules at lateral edge of right pectoralis major.				

PATHOLOGY REPORT

GROSS: Three specimens received as:

- 1). Completion mastectomy specimen: covered by skin ellipse including nipple and areola measured 13x4 cm, showing greyish areas admixed with fat.
- 2). Right axillary fibrotic nodule: Greyish piece measured 1.5x0.5 cm, totally embedded.
- 3). Fibrotic nodules at lateral edge of right pectoralis major: Greyish pieces, 1.5x1.5 cm, totally embedded.

MICROSCOPIC PICTURE: Sections examined from specimens (1) & (2) revealed reactive site changes with mild inflammatory cellular infiltrate associated foreign body giant cell reaction, fat necrosis & dense stromal fibroplasia. Sections examined from the nipple and areola as well as deep resection margin was free from tumor infiltration. Sections examined from specimen (3) reveal fibrotic tissue entangling focus of intermediate grade duct carcinoma insitu (clinging & micropapillary patterns).

DIAGNOSIS: Right Breast Mass, Completion mastectomy.

Specimens (1 & 2):

Reactive Site Changes, With Fat Necrosis & Foreign Body Giant Cell Reaction.
Free Nipple and Areola.

Specimen (3): Fibrotic nodules at lateral edge of right pectoralis major:

Focus of Intermediate Grade Duct Carcinoma insitu.

Dr. Somia Soliman; MD

Dr. Ahmed Naeem; MD

Dr. Mohamed Sherif; MD

Somia A. Lateef

A. Naeem

M. Sherif

برج نؤفة فيصل - شارع فيصل الرئيسي - أمام كلية التربية الرياضية - الدور الثاني



Faisal Pearl Tower in front of Faculty of Physical Education - Second Floor



02 35936015 - 01142299928

٠١١٤٢٢٩٩٩٢٨ - ٠٢ ٣٥٩٣٦٠١٥

